

التميّز التشغيلي · من الدراسات العلمية

يحلّ الموظف المشكلة بنفسه، فتعود إليه في اليوم التالي.

وفي 93% من الحالات لم يعلم بها أحد.

لاحظت ذلك دراسة ميدانية في مستشفيات أمريكية، وبعد أكثر من عشرين عامًا وجدت دراسة حديثة النمط نفسه تقريبًا.

← اسحب للمتابعة

الدراسة

ما الذي رأته الباحثتان؟

أمضت الباحثتان أنيتا تاكر وإيمي إدموندسون 239 ساعة تراقبان عمل 26 ممرضًا وممرضة في تسعة مستشفيات أمريكية، اختير أكثرها لأنه معروف بجودة التمريض.

ورصدتا خلال ذلك 194 خللًا في العمل اليومي، أغلبها مشكلات مألوفة: دواء لم يصل، أو جهاز معطّل، أو مستلزمات نفدت، أو وجبة عادية قُدّمت لمريض سكري.

لم تكن مشكلات معقدة، ولم يكن حلّها يحتاج إلى خبرة نادرة.

مثال من الدراسة

حلٌّ يُنهي الموقف، وحلٌّ يُنهي المشكلة

نفدت الأغطية النظيفة في نوبة ليلية، فأخذت الممرضة ما تحتاج إليه من قسم آخر وأكملت عملها. انتهى الموقف، لكن شيئًا لم يمنع تكرار المشكلة في الليلة التالية.

والحل الآخر أن تُكمل عملها، ثم تُبلغ القسم المسؤول عن الأغطية أو مديرها، حتى يُعالَج السبب.

تسمّي الدراسة الأول First-order problem solving، أي معالجة المشكلة في لحظتها، والثاني Second-order problem solving، أي معالجة سببها حتى لا تتكرر.

Tucker & Edmondson, CMR, 2003

النتائج

أُغلب المشكلات عولجت في لحظتها، ثم نُسيت

93%

من المشكلات اكتفى فيها الطاقم بما يُمكّنه من إكمال العمل، دون أن يُبلغ أحدًا.

7%

فقط من الحالات نُبِّه فيها من يملك إصلاح السبب، مع أن الباحثتين لم تتشددا في الحكم.

33

دقيقة تضيع في المتوسط من كل نوبة مدتها ثماني ساعات، في معالجة أعطال كان يمكن التخلص منها.

Tucker & Edmondson, CMR, 2003

ولم يكن السبب تقصيرًا

الممرضون كانوا يبذلون أكثر مما يُطلب منهم

تسعة من كل عشرة ممرضين راقبتهم الباحثتان طوال النوبة بقوا بعد انتهائها 45 دقيقة في المتوسط، بلا أجر إضافي، ليُكملوا رعاية مرضاهم.

وقال سبعة من تسعة ممن قابلتهم الباحثتان إنهم يشعرون بالرضا حين يجدون طريقة يتجاوزون بها العائق.

وهنا المفارقة: كلما نجح الموظف في التعامل مع المشكلة وحده، بقيت مخفية عمّن يستطيع إصلاحها.

Tucker & Edmondson, CMR, 2003

وبعد أكثر من عشرين عامًا

رأى الطاقم المشكلة، لكنه لم يُبلغ عنها في الغالب

96.2%

من الأعطال المقصودة في بيئة محاكاة لاحظها 80 ممرضًا وممرضة في دراسة بلجيكية نُشرت عام 2026.

21.9%

فقط من الحالات عولج فيها السبب بالإبلاغ الرسمي أو برفع المشكلة إلى المسؤول.

ولم تزد قصة مؤثرة عن سلامة المرضى من الإبلاغ، مع أنها أثارت مشاعر قوية.

Vanbelleghem et al., J Adv Nurs, 2026

TAMAYUZ 10X

ما الذي يستطيع القائد فعله؟

1

أن يحضر إلى موقع العمل في كل نوبة ولو وقتًا قصيرًا، فتصله المشكلات الصغيرة قبل أن تتراكم.

2

أن يجعل الإبلاغ عن المشكلة أمرًا آمنًا، لا يُفهم منه أن صاحبه عاجز عن عمله.

3

أن يستجيب لكل بلاغ بإجراء يراه الفريق، ويخصص نقاشًا قصيرًا بعد العمل يسأل فيه: ما الذي عطّلنا اليوم؟

> **كم مشكلة حلّها فريقك اليوم بنفسه، وستعود إليه غدًا؟**

حدود هذه الأدلة

دراسة 2003 نوعية بعيّنة صغيرة، ونسبها تخص ما رُصد أثناء المراقبة.

دراسة 2026 أُجريت في بيئة محاكاة لا في جناح حقيقي، وشملت 80 مشاركًا.

لم تشمل الدراستان مستشفيات عربية، وتعميم الفكرة على قطاعات أخرى استنتاج.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Tucker, A. L., & Edmondson, A. C. (2003). Why Hospitals Don't Learn from Failures. *California Management Review*, 45(2), 55–72.

[2] Vanbelleghem, S., De Regge, M., Van Nieuwenhove, Y., & Gemmel, P. (2026). Embedding Sustainable Second-Order Problem-Solving Behaviour in Hospital Nurses via Simulation-Based Education. *Journal of Advanced Nursing*.

المقال الكامل: tamayuz10x.com/article-oe-evidence-workarounds-hide-problems.html

